EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 85732
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 31-05-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: UBERLINDA DE LAS ROS CONCHA VASQUEZ			**RUN**	: 8.066.240-8
F.Nac	: 20-01-1959	**Edad**	: 65 AÑOS, 4 MESES	**Género**	: Femenino
Dirección	: LA NUEVA VIDA PASAJE LA LUNA 676			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 992639690		
Fecha Ingreso	: 2024-05-19	**Fecha Egreso**	: 31-05-2024	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. R06.0-DISNEA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1-SDRA (Neumonia aspirativa)
2-EPOC exacerbado
3-IC (FEVI conservada)
4-DM2NIR
5-ACV secuelar
6-UPP sacra
7-Limitación severa ABVD
8-TEP en TACO
9-ITU 2ria a E, faecium tratada

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. R06.0-DISNEA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE CONOCIDA DEL SERVICIO, ANTECEDENTES CONOCIDOS (REFERIDOS EN DIAGNOSTICOS) ALTERNANTE ENTRE HODOM Y VARIAS HOSPITALIZACIONES POR HIPERSECRESION Y DESATURACION SECUNDARIA.
CON ANTECEDENTES DE HOSPITALIZACIÓN RECIENTE POR NEUMONÍA ASPIRATIVA COMPLETÓ ESQUEMA DE ATB TAZONAM POR 20 DIAS , POSTERIORMENTE 10 DIAS DE LINEZOLID POR CULTIVO SENSIBLE AISLADO. EGRESADA A HODOM EL DIA PREVIO A CONSULTA EN URGENCIA.. FAMILIAR REFIERE DESATURACIÓN DURANTE LA TARDE MAS RUIDOS BRONQUIALES.
USUARIA INGRESA UX POR CUADRO DE DISNEA Y DESATURACIÓN BAJO 60% A FIO2 AMB. SE ENCUENTRA SOMNOLIENTA VIGIL, RESPONDE A ESTÍMULOS, SIN APREMIO VENTILATORIO, ACIANÓTICA, WOB (-), SIN UMA, SAT 85% CON MV AL 30% DE FIO2, A LA AUSC: MP (+) DISMINUIDO GLOBALMENTE, RONCUS VAS + CREPITOS BIBASALES.
PACIENTE AL DESTETAR DE O2 CON DESATURACION HASTA 84-85% CON FR 36 , SE DECIDE INGRESO HOSPITALARIO.
DURANTE ESTADIA HOSPITALARIA, CON REQUERIMIENTOS FLUCTUANTES DE O2, REQUERIMIENTO DE MANEJO DE SECRESIONES POR KINE, COMPLETA 1 SEMANA DE TTO ATB CON MEROPENEM, RESPUESTA REGULAR PERO FABORABLE.
HOY, 11° DIAS HOSP. AL EX VIGIL, SIN CONEXION CON EL MEDIO, ENFLAQUECIDA Y SARCOPENICA +++. FUE VALORADA POR CIRUGIA, SIN INDICACION ASEO QX DE UPP.
PACIENTE EVOLUCIONA ESTACIONARIAMENTE, PERO SIN REQUERIMIENTO DE O2 ULTIMOS DIAS, HDN ESTABLE, AFEBRIL, SE REALIZA EDUCACION A FAMILIARES SOBRE MANEJO Y ASPIRACION DE

SECRESIONES (YA TIENEN BOMBA DE ASPIRACION), PCTE EN CONDICIONES ESTABLES PARA CONTINUAR MANEJO POR HODOM, POR LO QUE SE EGRESA

INDICACIONES AL ALTA

1. A HODOM
2. REPOSO SEMISENTADA 30°
3. MANEJO Y PREVENCIÓN DE UPP
4. REGIMEN POR SNG + AGUA 200 CC C 4HRS (INDICACIONES POR NUTRICION)
5. LIMPIEZA DE CAVIDAD ORAL, MOJAR LABIOS Y LENGUA CON ALGODÓN EMBEBIDO EN AGUA
6. KNT RESPIRATORIA Y MOTORA 2 VECES AL DIA
7. MANEJO Y ASPIRACIÓN DE SECRECIONES
8. INS NPH 22U AM - 12 U PM SC
9. VITAMINA TOL 12 1 AMP IM POR SEMANA O CADA 5 DIAS
10. DABIGATRAN 110 MG UNIDAD UNIDAD 1 unidad cada 12 hrs. via ORAL
11. FAMOTIDINA COMPRIMIDO 40 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. via ORAL
12. CARVEDILOL COMPRIMIDO 6,25 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. via ORAL
13. LEVETIRACETAM COMPRIMIDO 500 MILÍGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. s via ORAL
14. AMITRIPTILINA COMPRIMIDO 25 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. via ORAL, NOCHE
15. QUETIAPINA COMPRIMIDO 25 MILIGRAMOS 1/2 comprimido cada 24 hrs. via ORAL, NOCHE
16. ATORVASTATINA COMPRIMIDO 40 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. via ORAL
17. IPRATROPIO INHALADOR FRASCO UNIDAD via INHALATORIA; 2 A 4 PUFF C/6 H
18. FLUTICASONA/SALMETEROL INHALADOR 250 MICROGRAMOS / 25 MICROGRAMOS via INHALATORIA: 2 PÚFF C/12 H
19. PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 MILÍGRAMOS 2 comprimido cada 8 hrs. via ORAL, SOS SI DOLOR O FIEBRE

OMAR ULLOA GUTIERREZ
MEDICO TRATANTE
13102850-4

JEFE SERVICIO